PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 3 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

3.1 Cuidados perioperatórios na clínica cirúrgica

Pré-operatório imediato (24 h antes): jejum (em geral 8 h para sólidos e 2 h para líquidos claros, conforme protocolo de abreviação do jejum), higiene corporal, tricotomia apenas quando necessária e **o mais próximo possível da cirurgia, com tricotomizador elétrico** (lâmina aumenta o risco de infecção de sítio cirúrgico), retirada de próteses, adornos e esmalte, esvaziamento vesical, sinais vitais, conferência do termo de consentimento, pulseira de identificação e demarcação de lateralidade.

Pós-operatório imediato (primeiras 24 h): controle de sinais vitais, nível de consciência, dor, curativo (sangramento), drenos, diurese, náuseas e vômitos. Estimular **deambulação precoce** e exercícios respiratórios para prevenir trombose venosa profunda (TVP), atelectasia e pneumonia.

Complicações pós-operatórias clássicas: hemorragia e choque (taquicardia, hipotensão, palidez, sudorese fria), **atelectasia** (mais comum nas primeiras 48 h), TVP/embolia pulmonar, retenção urinária, íleo paralítico, infecção de sítio cirúrgico (em geral entre o 3º e o 7º dia) e **deiscência** (abertura da ferida) ou **evisceração** (saída de vísceras – cobrir com compressa estéril úmida em SF 0,9% e comunicar imediatamente).

Drenos: Penrose (laminar, drenagem por capilaridade), tubular, de sucção (Portovac, Hemovac – pressão negativa) e **dreno de tórax em selo d'água**: o frasco fica sempre abaixo do nível do tórax; a extremidade do tubo fica submersa cerca de 2 cm na água; observar **oscilação** da coluna líquida com a respiração (indica sistema pérvio); pinçar o dreno apenas em situações específicas (troca do frasco), nunca durante o transporte de rotina.

3.2 Afecções clínicas mais cobradas

Doença	Fisiopatologia	Sinais e sintomas	Cuidados de enfermagem
Insuficiência cardíaca congestiva	Coração não bombeia o suficiente; congestão pulmonar (IC esquerda) ou sistêmica (IC direita)	Dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, turgência jugular, ganho de peso	Posição Fowler, restrição hídrica e de sódio, **peso diário**, balanço hídrico, controle de diuréticos e digitálicos (verificar pulso apical antes do digitálico)
Infarto agudo do miocárdio	Oclusão coronariana e necrose do músculo cardíaco	Dor torácica em aperto, irradiada para braço esquerdo, mandíbula ou dorso, > 20 min, sudorese, náuseas	Repouso, O2 se SpO2 < 90%, ECG em até 10 min, acesso venoso, monitorização, administração do protocolo (AAS, nitrato etc.)
AVC isquêmico/hemorrágico	Obstrução ou rompimento de vaso cerebral	Desvio de rima, fraqueza em um lado, alteração da fala (SAMU)	Cabeceira 0–30° conforme protocolo, avaliação neurológica, prevenção de broncoaspiração, glicemia, mudança de decúbito
DPOC	Bronquite crônica + enfisema, limitação ao fluxo aéreo	Tosse produtiva, dispneia progressiva, tórax em tonel	O2 em baixo fluxo (1–2 L/min ou Venturi), alvo SpO2 88–92%, respiração com lábios semicerrados
Pneumonia	Infecção do parênquima pulmonar	Febre, tosse produtiva, dor torácica, taquipneia	Hidratação, fisioterapia respiratória, antibiótico no

			horário, cabeceira elevada
Cirrose hepática	Fibrose do fígado; hipertensão portal	Ascite, icterícia, varizes esofágicas, encefalopatia	Medir circunferência abdominal, peso diário, dieta conforme prescrição, observar sangramentos e confusão mental
Insuficiência renal aguda	Queda súbita da filtração glomerular	Oligúria, edema, hiperpotassemia, ureia elevada	Balanço hídrico rigoroso, peso diário, controle de potássio, cuidados com fístula/cateter de diálise

3.3 Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A UTI atende pacientes graves ou potencialmente graves, com monitorização contínua. Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 7/2010**, que exige no mínimo **1 técnico de enfermagem para cada 2 leitos** em cada turno, além de 1 enfermeiro assistencial para cada 8 leitos.

Monitorização: cardioscópio (ECG contínuo), oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (PANI) e invasiva (PAI – via cateter arterial, geralmente radial), pressão venosa central (PVC, valor de referência aproximado de 3 a 8 cmH2O ou 2 a 6 mmHg), capnografia, débito urinário horário.

Ventilação mecânica e cuidados ao paciente intubado (bundle de prevenção da PAV):

- Cabeceira elevada entre **30° e 45°**.
- Higiene oral com clorexidina 0,12% (ou conforme protocolo).
- Manter a pressão do **cuff entre 20 e 30 cmH2O** (ou 18 a 22 mmHg).
- Interrupção diária da sedação e avaliação do desmame (ação médica/multiprofissional).
- Aspiração traqueal com **técnica estéril** em sistema aberto, por no máximo **10 a 15 segundos**, com pré-oxigenação; sistema fechado (trach care) reduz contaminação e perda de PEEP.
- Ordem da aspiração no sistema aberto: **tubo/traqueostomia → nariz → boca** (do mais limpo para o mais contaminado).

Sedação e dor: escala de **RASS** (Richmond, de +4 combativo a –5 não despertável; 0 = alerta e calmo) e escala de Ramsay (1 a 6). Avaliação de dor em paciente não comunicativo: escala BPS (Behavioral Pain Scale).

Cateter venoso central (CVC): curativo com gaze (troca a cada 48 h) ou filme transparente (troca a cada 7 dias), ou antes se úmido, solto ou sujo; desinfecção dos conectores com álcool 70% por 5 a 15 segundos antes de cada acesso (*scrub the hub*).

Choque (hipoperfusão tecidual): hipovolêmico (perda de volume), cardiogênico (falha da bomba), distributivo (séptico, anafilático, neurogênico) e obstrutivo (tamponamento, pneumotórax hipertensivo, TEP). Sinais: hipotensão, taquicardia, pele fria e pegajosa, enchimento capilar > 2 s, oligúria, alteração do nível de consciência.

Sepse: disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por resposta desregulada à infecção. Pacote da 1ª hora: coleta de lactato, **hemoculturas antes do antibiótico**, antibiótico de amplo espectro, reposição volêmica (30 mL/kg de cristaloide se hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol/L) e vasopressor se hipotensão persistente.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Tricotomia: só se necessária, próxima à cirurgia, com tricotomizador elétrico.

- Deambulação precoce para prevenir TVP e complicações respiratórias.
- Evisceração: compressa estéril úmida com SF 0,9% e comunicar.
- Dreno de tórax: frasco abaixo do tórax, oscilação, selo d'água.
- ICC: peso diário, Fowler, restrição hídrica e de sódio; pulso apical antes do digitálico.
- DPOC: O2 em baixo fluxo.
- Bundle de PAV: cabeceira 30–45°, cuff 20–30 cmH2O, higiene oral.
- Aspiração: estéril, máximo 15 s, tubo → nariz → boca.
- RDC 7/2010: 1 técnico para 2 leitos.
- Hemocultura antes do antibiótico na sepse.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"30-30-15"**: cabeceira a 30° (ou mais), cuff entre 20 e 30, aspiração por até 15 s.
- **"ICC pesa todo dia"**: peso diário é o melhor indicador de retenção hídrica.
- **"DPOC gosta de pouco oxigênio"**: alto fluxo pode deprimir o estímulo respiratório.
- **"Tubo, nariz, boca"**: do mais limpo para o mais sujo na aspiração.
- **"Cultura antes, antibiótico depois"**.
- **"Dreno que oscila está vivo"**: oscilação indica sistema pérvio.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Paciente no 5º dia de pós-operatório de laparotomia apresenta, após esforço de tosse, saída de alças intestinais pela incisão. A conduta imediata do técnico em enfermagem é:

(A) recolocar as alças na cavidade abdominal com luvas estéreis.
(B) cobrir as vísceras com compressa estéril umedecida em soro fisiológico 0,9% e comunicar imediatamente a equipe.
(C) aplicar curativo compressivo seco com esparadrapo.
(D) colocar o paciente sentado e estimular a deambulação.
(E) aguardar a visita médica para decidir a conduta.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a reintrodução das vísceras é ato cirúrgico, nunca realizada pela enfermagem no leito.

B) Correta – a evisceração exige proteção das alças com compressa estéril úmida para evitar ressecamento e contaminação, além de comunicação imediata.

C) Incorreta – curativo seco e compressivo pode lesar as alças.

D) Incorreta – a posição indicada é dorsal com joelhos levemente fletidos, para reduzir a tensão abdominal.

E) Incorreta – é uma emergência cirúrgica; não se aguarda a visita.

QUESTÃO 02

Entre as medidas do pacote (bundle) de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, inclui-se:

(A) manter a cabeceira em decúbito zero.
(B) manter a pressão do cuff entre 20 e 30 cmH2O.
(C) trocar o circuito do ventilador diariamente.
(D) realizar aspiração traqueal com técnica limpa.
(E) manter a sedação contínua sem interrupção.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a cabeceira deve ficar entre 30° e 45°.

B) Correta – a pressão adequada do cuff evita microaspiração de secreções (pressão baixa) e lesão traqueal (pressão alta).

C) Incorreta – o circuito só é trocado se houver sujidade ou mau funcionamento; trocas rotineiras não reduzem PAV.

D) Incorreta – a aspiração em sistema aberto exige técnica estéril.

E) Incorreta – recomenda-se a interrupção diária da sedação.

QUESTÃO 03

Paciente com insuficiência cardíaca congestiva está internado em uso de furosemida e digoxina. Constitui cuidado de enfermagem adequado:

(A) estimular a ingestão hídrica livre.
(B) manter o paciente em decúbito dorsal horizontal.
(C) verificar o peso diariamente, em jejum, na mesma balança.
(D) oferecer dieta rica em sódio para compensar o diurético.
(E) administrar a digoxina mesmo com pulso apical abaixo de 60 bpm.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – na ICC geralmente há restrição hídrica.

B) Incorreta – a posição de Fowler alivia a dispneia.

C) Correta – o peso diário, sempre nas mesmas condições, é o melhor indicador de retenção de líquidos.

D) Incorreta – a dieta é hipossódica.

E) Incorreta – pulso apical abaixo de 60 bpm é sinal de alerta para intoxicação digitálica; a dose deve ser suspensa e o enfermeiro/médico comunicado.

QUESTÃO 04

Sobre a aspiração de secreções em paciente com tubo orotraqueal em sistema aberto, é correto afirmar:

(A) a sonda deve permanecer aspirando por até 1 minuto contínuo.
(B) a sequência correta é boca, nariz e tubo orotraqueal.
(C) a técnica é estéril, com duração máxima de 10 a 15 segundos por aspiração.
(D) a pré-oxigenação é contraindicada.
(E) a mesma sonda pode ser reutilizada em vários horários se guardada em SF.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a aspiração prolongada causa hipoxemia, bradicardia e lesão da mucosa.

B) Incorreta – a ordem é tubo → nariz → boca.

C) Correta – técnica estéril, aspirando apenas na retirada da sonda, por no máximo 10 a 15 s.

D) Incorreta – a pré-oxigenação é recomendada para evitar hipoxemia.

E) Incorreta – no sistema aberto a sonda é descartável e de uso único.

QUESTÃO 05

Em relação ao paciente com dreno de tórax em selo d'água, assinale a alternativa correta.

(A) O frasco coletor deve ser mantido acima do nível do tórax.

(B) A ausência de oscilação da coluna líquida sempre indica cura.

(C) O dreno deve ser pinçado rotineiramente durante todos os transportes.

(D) A extremidade do tubo deve permanecer submersa na água do frasco, e a oscilação acompanha os movimentos respiratórios.

(E) O frasco pode ser esvaziado sem pinçamento enquanto o paciente tosse.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – o frasco acima do tórax faz o líquido refluir para a cavidade pleural.

B) Incorreta – a falta de oscilação pode indicar obstrução, dobra do tubo ou reexpansão pulmonar; precisa ser avaliada.

C) Incorreta – o pinçamento rotineiro pode causar pneumotórax hipertensivo; mantém-se o frasco abaixo do tórax.

D) Correta – o selo d'água impede a entrada de ar e a oscilação mostra que o sistema está pérvio.

E) Incorreta – a troca do frasco requer pinçamento breve e técnica adequada.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: pré e pós-operatório; complicações (atelectasia, TVP, deiscência, evisceração); drenos; ICC, IAM, AVC, DPOC, pneumonia, cirrose, IRA; UTI (RDC 7/2010); monitorização; ventilação mecânica e PAV; aspiração; RASS; CVC; choque e sepse.

Quadro-resumo: cabeceira 30–45°; cuff 20–30 cmH2O; aspiração ≤ 15 s; 1 técnico/2 leitos; curativo de CVC: gaze 48 h, filme 7 dias; DPOC: SpO2 88–92%.

Pegadinhas: tricotomia com lâmina na véspera; frasco de dreno acima do tórax; aspiração boca → tubo; alto fluxo de O2 no DPOC.

Erros comuns: achar que evisceração se resolve com curativo seco; esquecer o pulso apical antes do digitálico; iniciar antibiótico antes da hemocultura na sepse.